

Kryteria *diagnostyczne*

DSM-5 F50.2 i ICD-11 6B81 — pięć kryteriów. Częstotliwość, czas trwania, rdzeń overvaluation. Subkliniczne formy (OSFED) też wymagają leczenia.

CZAS: 15 min · diagnostyka · Sesja diagnostyczna · różnicowanie

ŹRÓDŁO: APA (2013, DSM-5); WHO (2019, ICD-11); Fairburn (2008)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **pięć kryteriów DSM-5** dla bulimii (sekcja 1), zobacz **różnice DSM-5 vs ICD-11** (sekcja 2). W sekcji 3 — **kategorie subkliniczne (OSFED)**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

APA (2013) w DSM-5 i WHO (2019) w ICD-11 dostarczają standardów diagnostycznych dla bulimii (BN). Główne kryteria są zbieżne, ale różnią się w szczegółach. DSM-5 wymaga ilościowo-objektywnej definicji „*dużej ilości jedzenia*”; ICD-11 kładzie nacisk na *subiektywne* poczucie utraty kontroli. Częstotliwość: **co najmniej raz w tygodniu przez 3 miesiące**. Pacjenci poniżej progu klasyfikowani są jako **OSFED i też wymagają leczenia**, bo cierpienie i mechanizm są te same. Hudson i in. (2007, NCS-R): około 50% klinicznie istotnych ED spełnia kryteria OSFED, nie pełnej BN — nie powinno to być powodem odmowy leczenia.

01 📄 Pięć kryteriów DSM-5 (F50.2)

A · EPIZODY OBJADANIA

A1) zjadanie w ograniczonym czasie (np. 2 h) ilości jedzenia *definitywnie większej* niż większość osób zjadłaby w podobnym czasie; A2) poczucie **utraty kontroli** nad jedzeniem.

B · ZACHOWANIA KOMPENSACYJNE

Nawracające zachowania zapobiegające przyrostowi masy: samoindukowane wymioty, środki przeczyszczające, diuretyki, inne leki, głodówka, nadmierne ćwiczenia.

C · CZĘSTOTLIWOŚĆ I CZAS

Objadanie i kompensacja występują **średnio $\geq 1 \times$ / tydzień przez 3 miesiące**. Próg formalny. Poniżej — kategoria OSFED, też wymagająca leczenia.

D · OVERVALUATION

Samooocena *nadmiernie* kształtowana przez masę i kształt ciała. To rdzeń poznawczy bulimii — kryterium wymagane (nie opcjonalne).

E · WYKLUCZENIE ANOREKSJI

Objawy **nie** występują wyłącznie podczas epizodu anoreksji (AN). Jeśli osoba ma BMI poniżej progu AN — diagnoza to AN typ binge-purge, nie BN. Rozróżnienie istotne dla planowania leczenia.

02 🔄 DSM-5 vs ICD-11 — różnice

DSM-5 (F50.2)

Wymaga **objektywnej** definicji „*dużej ilości jedzenia*”. Standard amerykański, częściej używany w badaniach naukowych i RCT.

ICD-11 (6B81)

Wystarczy **subiektywne** poczucie utraty kontroli. Standard WHO, używany w Polsce. Szerszy zakres — obejmuje pacjentów z mniejszymi epizodami, ale pełnym mechanizmem.

Praktyczna konsekwencja: osoba może mieć *subiektywne* epizody objadania (mniejsze obiektywnie, ale z pełnym poczuciem utraty kontroli) i nadal spełniać kryteria ICD-11. To ważne — wielu pacjentów uważa, że *nie mam bulimii, bo nie objadam się tysiącami kalorii*". Subiektywna utrata kontroli i kompensacja wystarcza do rozpoznania zaburzenia i wskazania leczenia.

03 OSFED — formy subkliniczne

OSFED (*Other Specified Feeding or Eating Disorder*) to kategoria DSM-5 obejmująca osoby z **klinicznie istotnymi** objawami, które nie spełniają pełnych kryteriów BN, BED ani AN. Hudson i in. (2007): ~50% wszystkich klinicznych ED mieści się w OSFED — to *nie* jest „łagodniejsza forma”, to często ten sam mechanizm w innej proporcji.

ATYPOWA BULIMIA

Wszystkie kryteria BN, ale częstotliwość poniżej progu (np. 1×/2 tyg.) lub czas krótszy niż 3 miesiące. **Wymaga leczenia** — mechanizm identyczny.

ZACHOWANIA OCZYSZCZAJĄCE BEZ OBJADANIA

Wymioty / środki przeczyszczające po *normalnych* posiłkach (bez epizodu objadania). Wysokie ryzyko somatyczne, niska rozpoznawalność.

ATYPOWA ANOREKSJA

Wszystkie kryteria AN, ale BMI *nie* poniżej progu. Pacjenci o normalnej lub wyższej masie z pełnym mechanizmem AN. Często niedoceniani.

NIGHT EATING SYNDROME

Wieczne/nocne epizody jedzenia z budzeniami się w nocy. Często współwystępujące z BN. Ma własny mechanizm rytmu dobowego.

04 Moja konsultacja — co zabieram do specjalisty

KTÓRE KRYTERIA MOGĘ SPEŁNIAĆ

— A, B, C, D — krótko opisz, bez ocen

PYTANIA DO SPECJALISTY

— co chcę zapytać o diagnozę, leczenie, kolejne kroki

Klucz: diagnoza formalna jest narzędziem klinicznym — pomaga uporządkować leczenie, ale *nie definiuje* Twojego cierpienia. Wielu pacjentów odraczała konsultację, sądząc, że „*nie mają wystarczająco poważnych objawów*” — to pułapka. Mechanizm bulimii podtrzymuje się **niezależnie** od częstotliwości — jeden epizod tygodniowo, jak i pięć dziennie, działa według tej samej logiki. Im wcześniej zaczyna się leczenie, tym lepsze rokowanie (Treasure i in. 2015): pacjenci z BN do 3 lat od początku objawów osiągają pełną remisję w 70%, po 10 latach — w 30-40%. Konsultacja diagnostyczna to **pierwszy krok**, nie ostateczny wyrok. NICE (2017): osoby z podejrzeniem ED powinny mieć dostęp do specjalistycznej oceny w ≤ 4 tygodni. W Polsce: **poradnie zaburzeń odżywiania**, centra terapii zaburzeń odżywiania, NFZ-owe ośrodki specjalistyczne.